

1. אבחון הריון ומידע ראשוני

אבחון הריון ראשוני מתבסס על זיהוי הורמון ה-HCG, אך לצורך ביצוע הפסקה ניתוחית חיוני לבצע אולטרסאונד שמאשר מיקום תוך-רחמי וקובע את גיל ההריון המדויק. הפסקה ניתוחית (גרידה או שאיבה) היא הליך כירורגי קצר המבוצע תחת הרדמה כללית, ובו מרוקנים את תוכן הרחם. שיטה זו נחשבת ליעילה ביותר (קרוב ל-99% הצלחה בפעולה אחת) ומתאימה לנשים המעוניינות לסיים את התהליך במפגש אחד או במקרים בהם קיימת התוויית-נגד רפואית לטיפול תרופתי.

שאלה: איך אני יודעת שאני בהריון?

תשובה: איחור במחזור הוא הסימן העיקרי, לצד בחילות, עייפות ורגישות בשדיים. ניתן לאשר זאת בבדיקת שתן ביתית החל מיום האיחור בוסת. לאחר בדיקת שתן חיובית יש לתאם אולטרסאונד אצל רופא נשים סביב שבוע 8.

תגיות: אבחון הריון, וסת אחרונה

שאלה: איך אני יודעת מה שבוע ההריון שלי? באיזה חודש אני?

תשובה: מחשבים את שבוע ההריון לפי היום הראשון של הווסת האחרונה. ניתן גם לקבוע את גיל ההריון באמצעות אולטרסאונד וגילי המודד את קוטר השק או אורך העובר להערכה מדויקת.

תגיות: שבוע הריון, אולטרסאונד

שאלה: אני בהריון!! מה לעשות?

תשובה: יש לבצע אולטרסאונד ראשון בין שבועות 6-8, להקפיד על חומצה פולית (400 מק"ג) ולא להפסיק תרופות קבועות ללא ייעוץ רופא. אם ההריון אינו רצוי, ניתן לפנות לשירות הסוציאלי לתיאום ועדה.

תגיות: הריון, בדיקות בהריון, חומצה פולית

שאלה: אילו שיטות קיימות בבית חולים וולפסון להפסקת הריון יזומה?

תשובה: קיימות שתי אפשרויות: הפסקת הריון תרופתית והפסקת הריון ניתוחית. השיטה התרופתית מבוצעת עד שבוע 9 וכוללת נטילת מפיג'ין וציטוטק. השיטה הניתוחית (גרידה או שאיבה) היא פעולה קצרה תחת הרדמה מלאה וריקון תוכן הרחם תחת הנחיית אולטרסאונד.

תגיות: שיטות טיפול, וולפסון

שאלה: באיזה מקרים לא ניתן לבצע הפסקת הריון תרופתית? מהן התוויות הנגד?

תשובה: הרופא ימליץ להימנע מהשיטה התרופתית במקרים של הריון מעל שבוע 9+0, אנמיה קשה (המוגלובין מתחת ל-9), נוכחות התקן תוך רחמי, הפרעות קרישה, מחלת כבד פעילה, אסטמה, או אי-יכולת לעמוד במעקב.

תגיות: התוויות נגד, טיפול תרופתי

2. הוועדה להפסקת הריון

הוועדה להפסקת הריון פועלת מתוקף חוק העונשין (1977) ומטרתה להסדיר את התהליך מבחינה רפואית וחוקית בישראל. הוועדה מורכבת מפאנל מקצועי הכולל שני רופאים ועובדת סוציאלית, ותפקידה לוודא כי הבקשה עומדת באחד הקריטריונים הקבועים בחוק (למטה מגיל 18, מחוץ לנישואים, ההריון נובע מיחסים אסורים, התינוק עלול להיוולד בעל מום או המשך ההריון עלול לסכן את חייו). תהליך זה נועד להבטיח כי האישה מקבלת את כל המידע הרפואי הנדרש ומעטפת סוציאלית תומכת.

שאלה: למה צריך ועדה?

תשובה: בישראל הפסקת הריון מוסדרת בחוק משנת 1977, המחייב פנייה לוועדה בבית חולים מורשה כדי לשקול את הבקשה לפי קריטריונים חוקיים.

תגיות: ועדה, חוק

שאלה: האם לרוב הוועדה מאפשרת הפסקת הריון?

תשובה: כן, הסטטיסטיקה מראה כי כ-99% מהבקשות המוגשות לוועדה להפסקת הריון מאושרות.

תגיות: ועדה, אישור

שאלה: מי יכולה לפנות לוועדה?

תשובה: כל אישה בישראל, ללא קשר לגיל או מעמד אישי.

תגיות: ועדה, קריטריונים

שאלה: מה הרכב הנוכחים בוועדה?

תשובה: שני רופאים (לרוב גינקולוג בכיר ורופא נוסף) ועובדת סוציאלית.

תגיות: ועדה, הרכב

שאלה: עברתי היום ועדה. מה השלב הבא?

תשובה: אישור הוועדה יישלח לדוא"ל שלך, ולאחריו תוכלי לקבוע תור לביצוע ההליך הניתוחי בבית החולים.

תגיות: ועדה, המשך תהליך

שאלה: האם אב העובר צריך להיות בוועדה? האם יש צורך בהסכמת השותף?

תשובה: לא, לבן הזוג אין מעמד חוקי בוועדה והסכמתו אינה נדרשת. את המחליטה הבלעדית על גופך.

תגיות: ועדה, בן זוג

שאלה: האם אני חייבת להתייצב מול הוועדה?

תשובה: לא, ניתן לבצע הליך מקוון בקישור:

<https://www.gov.il/he/service/pregnancy-termination-committee>

תגיות: ועדה, הליך מקוון

שאלה: באילו מקרים ניתן להפסיק הריון?

תשובה: מתחת לגיל 18 או מעל 40, הריון מיחסים אסורים (מחוץ לנישואין), חשש למום בעובר, או סיכון לחיי האישה או לנזק פיזי/נפשי.

תגיות: ועדה, חוק

שאלה: מה להביא לוועדה?

תשובה: תעודת זהות, הפניה, בדיקות דם (סוג דם וספירה) ואמצעי תשלום או טופס 17. חיילות צריכות אישור מיחידת מהו"ת.

תגיות: ועדה, הכנה

שאלה: כיצד פונים לוועדה להפסקת הריון?

תשובה: ניתן לפנות בהליך מקוון (עד שבוע 24) או להגיע לוועדה פרונטלית בבית החולים בימים א', ג', ה' בתיאום מראש.

תגיות: ועדה, דרכי פניה

3. עלויות, זכאויות ודיסקרטיות

מימון הפסקת הריון בישראל מוסדר דרך סל הבריאות וניתן לנשים העומדות בקריטריונים של גיל או סיבות רפואיות/אישיות. הטיפול כפוף לכללי סודיות רפואית מחמירים, וקיימים פרוטוקולים המאפשרים יצירת "תיק חסוי" להבטחת פרטיותה המלאה של המטופלת מול קופות החולים או גורמים חיצוניים.

שאלה: האם הטיפול להפסקת הריון עולה כסף?

תשובה: כן, הדיון וההליך כרוכים בתשלום לפי מחירון משרד הבריאות או הצגת טופס 17 מקופת החולים המבטחת.

תגיות: עלות, תשלום

שאלה: האם אני צריכה להביא טופס 17 לוועדה ולטיפול?

תשובה: ברוב המקרים כן, אך יש חריגים לפי הקופה; כדאי לוודא מול מוקד הקופה.

תגיות: טופס 17, קופת חולים

שאלה: מה העלות של הפסקת הריון?

תשובה: העלות משתנה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן במחירון משרד הבריאות באתר הרשמי.

תגיות: עלות, מחיר

שאלה: האם אני זכאית למימון של הפסקת הריון?

תשובה: מימון יינתן למי שקיבלה אישור ועדה (דרך סל הבריאות), לקטינות חסרות מעמד, לחיילות, ולעיתים לנשים המוכרות על ידי שירותי הרווחה.

תגיות: עלות, מימון

שאלה: האם הטיפול תועד בתיק הרפואי שלי? האם זה דיסקרטי?

תשובה: ניתן לבקש לשמור את הטיפול בגיליון חסוי בארכיון בית החולים, כך שלא תהיה גישה אליו לגורמים חיצוניים או לעובדים לא רלוונטיים.

תגיות: דיסקרטי, סודיות

שאלה: אני לא רוצה שהקרובים שלי ידעו

תשובה: הצוות מחויב לסודיות רפואית לפי חוק. ניתן לבקש גיליון חסוי שלא יהיה נגיש לקופות החולים או לכלל צוות בית החולים.

תגיות: סודיות, פרטיות

שאלה: "אני קטינה, האם אני יכולה לבצע הפסקת הריון על דעת עצמי בלבד?"

תשובה: כן, לפי החוק הסכמת קטינה אינה טעונה אישור הורים או אפוטרופוס, ונשמרת לה הזכות לסודיות רפואית מלאה.

תגיות: נערה, קטינה, סודיות

שאלה: אני קטינה וחסרת מעמד בישראל אין לי איך לשלם על הפסקת הריון

תשובה: משרד הבריאות נושא בכל ההוצאות עבור קטינה חסרת מעמד בישראל.

תגיות: קטינה, מימון, חסרת מעמד

4. יום הפעולה הניתוחית - הכנה, צום והרדמה

גרידה (D&C) מבוצעת לרוב תחת הרדמה כללית קצרה. ההכנה הקריטית ביותר היא שמירה על צום מוחלט כדי למנוע סיבוכים נשימתיים בזמן ההרדמה. הפעולה מתבצעת בחדר ניתוח יום, טרם הפעולה תקבלי טיפול אנטיביוטי (לרוב צפמזין 2 גר) במהלך הפעולה, הרופא מרחיב בעדינות את צוואר הרחם ומשתמש במכשיר שאיבה או במגדת כדי לרוקן את הרחם תחת בקרת אולטראסאונד רציפה.

שאלה: איך להיערך לפעולה?

תשובה: יש להגיע בצום מלא, להביא בדיקות דם (ספירה וסוג דם), אישור ועדה בתוקף, ולדאוג למלווה שייקח אותך הביתה.

תגיות: הכנה לגרידה

שאלה: האם עלי להיות בצום?

תשובה: כן, חובה להיות בצום מלא (אסור לאכול או לשתות) לפחות 8 שעות לפני הפעולה הניתוחית. ניתן לשתות מים צלולים בלבד עד שעתיים לפני הפעולה.

תגיות: צום, הרדמה

שאלה: מה קורה ביום הפעולה הניתוחית?

תשובה: תתקבלי במחלקת אשפוז, תעברי בדיקת אחות ושיחה עם המרדים והרופא, בסיום השיחה עם הרופא תקבלי שני כדורי ציטוטק (mcg misoprostol 400) להשמה מתחת לשון אשר מרככים את צוואר הרחם ומונעים טראומה ונזק לצוואר הרחם. עם כניסתך לחדר ניתוח תתקבלי ע"י צוות האחיות, יורכב לך עירוי ביד ע"י המרדים, הצוות ישאל בשנית את הפרטים המזהים שלך ותקבלי מנת אנטיביוטיקה (לרוב צפמזין 2גר) דרך הוריד. לאחר ההרדמה במהלך הפעולה, הרופא מרחיב בעדינות את צוואר הרחם ומשתמש במכשיר שאיבה או במגדת כדי לרוקן את הרחם תחת בקרת אולטראסאונד רציפה.

הפעולה עצמה קצרה, ולאחריה תשהיי בחדר התאוששות למשך כשעתיים. בסיום תשוחררי לביתך.

תגיות: יום הפעולה, אשפוז יום

שאלה: האם צריך להגיע עם מלווה?

תשובה: בהפסקת הריון ניתוחית חובה להגיע עם מלווה עקב ההרדמה הכללית.

תגיות: ליווי, בטיחות

שאלה: האם אני צריכה לקחת אנטיביוטיקה?

תשובה: אין צורך באנטיביוטיקה מונעת בבית. בתחילת הפעולה, רגע לפני ההרדמה, תקבלי עירוי של אנטיביוטיקה (לרוב צפמזין 2 גר') המשמשת למניעת זיהומים.

תגיות: אנטיביוטיקה, מניעה

שאלה: "אני מניקה, האם ניתן להמשיך להניק?"

תשובה: כן, ניתן להמשיך בהנקה. אומנם תרופות ההרדמה עוברות בחלב אם, אך כאשר את מתעוררת מהרדמה ומתמצאת, חומרי ההרדמה כבר כמעט ואינם בזרם הדם ולא יגיעו לתינוק.

תגיות: הנקה, הרדמה

שאלה: מדוע נאמר בוועדה להפסקת הריון שאני נדרשת לאולטרסאונד לפני הטיפול?

תשובה: לעיתים האולטרסאונד הקיים אינו מספק (חסר מידע על מיקום השק או שבוע מדויק), ולכן נדרשת הערכה חוזרת.

תגיות: אולטרסאונד, ועדה

5. לאחר הפעולה – תופעות, דימום והתאוששות

לאחר גרידה, הדימום הצפוי הוא בדרך כלל קל, בכמות פחותה מוסת. הרחם מתחיל להתכווץ חזרה לגודלו המקורי, מה שעלול לגרום לכאבים דמויי מחזור. רוב הנשים חוזרות לתפקוד מלא תוך יום-יומיים, אך חשוב לאפשר לגוף לנוח ולהקשיב לתסמינים הגופניים בשבוע הראשון.

שאלה: כמה זמן דימום לאחר הפעולה נחשב תקין?

תשובה: לאחר גרידה צפוי דימום בכמות מועטה בלבד למשך 3-4 ימים.

תגיות: דימום לאחר גרידה

שאלה: אילו תופעות לוואי צפויות? מה אני ארגיש?

תשובה: ייתכנו כאבי בטן תחתונה (התכווצויות רחם), בחילה קלה עקב חומרי ההרדמה, ודימום קל מהנרתיק.

תגיות: תופעות לוואי

שאלה: מהן התופעות התקינות? מה צפוי לי שלא מצריך פניה לרופא/מיון?

תשובה: דימום קל (פחות מווסת), התכווצויות קלות בבטן תחתונה הניתנות לשיכוך בכדורים, ועייפות קלה ביום הפעולה.

תגיות: תסמינים תקינים

שאלה: האם יש הבדל בין דימום רציף לדימום שבא והולך?

תשובה: הדימום יכול להיות רציף או להיעצר ולהתחדש לאחר שעות או ימים. כל עוד הוא לא זורם כמו "ברז" או מצריך החלפת פד ספוג ביותר מפעם בשעתיים, הוא נחשב תקין.

תגיות: דימום רציף, דימום מקוטע

שאלה: האם קרישי דם הם חלק מהתהליך?

תשובה: לא. לאחר גרידה צפוי דימום בכמות מועטה בלבד. לא צפוי דימום המלווה בקרישי דם. אירוע בודד אפשרי, אך אם מדובר באירועים חוזרים יש לפנות לבדיקת רופא.

תגיות: קרישי דם, גרידה

שאלה: האם אקבל ימי מחלה?

תשובה: מומלץ על 3 ימי מנוחה לאחר הפעולה. יש לפנות לרופא קופ"ח לקבלת אישור תקף.

תגיות: ימי מחלה, מנוחה

שאלה: מתי אפשר לחזור לפעילות רגילה?

תשובה: רוב הנשים מרגישות טוב כבר למחרת ויכולות לחזור מיד לפעילות שגרתית, אך מומלץ להימנע ממאמץ גופני קיצוני ב-3 הימים הראשונים.

תגיות: פעילות רגילה, התאוששות

שאלה: האם מותר לקחת משככי כאבים?

תשובה: כן, כל משכך כאבים שעוזר בזמן מחזור מתאים גם כאן (נורופן, אדוויל, אקמול, אופטלגין).

תגיות: משככי כאבים

שאלה: מה אם בזמן פעילות גופנית קלה אני שמה לב שהדימום מתגבר?

תשובה: התגברות דימום עקב מאמץ או שינוי תנוחה היא תופעה תקינה. עם זאת, אם מופיע דימום מוגבר מאוד (מעל שני פדים ספוגים בשעתיים), יש להיבדק מיד.

תגיות: דימום, פעילות גופנית

שאלה: מה ההנחיות לאחר ההליך?

תשובה: הנחיות לתקופת התהליך:

1. להימנע משימוש בטמפונים במשך כל זמן הדימום
2. להימנע מכניסה לים או לבריכה במשך שבועיים
3. להימנע מקיום יחסי מין למשך שבועיים
4. במקרה של עליית חום, כאבים חזקים או דימום מוגבר עליך להיבדק ע"י רופא נשים במייד
5. ביקורת נוספת אצל גניקולוג מטפל לאחר הופעת ווסת

תגיות: הנחיות, ים, בריכה, יחסי מין, חום

6. טיפול בשארית הריון

שארית של תוכן הריוני (RPOC) היא מצב שבו רקמה מההריון נותרת ברחם לאחר הפלה. השארית עלולה לגרום לדימום ממושך או לזיהום. הטיפול יכול להתבצע בגרידה חוזרת או בהיסטרוסקופיה טיפולית. היסטרוסקופיה מאפשרת לרופא לראות את תוכן הרחם באמצעות מצלמה ולהסיר רק את השארית באופן ממוקד, אך היא אינה אפשרית בכל המקרים וההחלטה על ההתערבות הניתוחית המתאימה תתבצע על פי שיקול דעת הרופא.

שאלה: האם יש טיפולים ניתוחיים אחרים להסרת שארית מלבד גרידה?

תשובה: כן, קיימת אפשרות של היסטרוסקופיה טיפולית, המשמשת בעיקר להוצאת שארית הריון תחת ראייה ישירה עם מצלמה.

תגיות: שיטות ניתוחיות, היסטרוסקופיה

שאלה: מה הסיכון שאצטרך התערבות ניתוחית לאחר טיפול תרופתי?

תשובה: בהפסקת הריון יזומה הסיכון לשארית מצריכת ניתוח הוא כ-5%, ובהפלה נדחית כ-15%.

תגיות: שארית, התערבות ניתוחית

7. דגלים אדומים ופנייה למיון

למרות שגרידה היא הליך בטוח מאוד, זיהוי מוקדם של סימני מצוקה הוא קריטי למניעת סיבוכים כמו זיהום רחמי או דימום חריג. חום גבוה או כאבים שאינם מגיבים למשככי כאב מחייבים הערכה רפואית מיידית במיון נשים.

שאלה: לאחר גרידה איזה סימפטומים דורשים פנייה מיידית?

תשובה: חום מעל 38.5 מעלות, דימום כבד ביותר (מעל שני פדים ספוגים בשעתיים), כאבי בטן חזקים מאוד שאינם מגיבים למשככי כאב, חולשה משמעותית, הפרשה בעלת ריח רע או איבוד הכרה.

תגיות: סימפטומים, פנייה מיידית

שאלה: אני מספר ימים אחרי גרידה ויש לי חום.

תשובה: חום לאחר פעולה ניתוחית עלול להעיד על התפתחות זיהום ברחם. עלייך לפנות לבדיקת רופא נשים או למיון נשים בהקדם.

תגיות: חום, זיהום

שאלה: יש לי חום מעל 38 מעלות שנמשך מעל יומיים, או חום מעל 39 מעלות. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במידי לבדיקת רופא נשים זמין או למיון נשים בבית החולים וולפסון (טלפון: 03-5028318, זמין 24/7).

תגיות: חום, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: אני חווה דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. דימום כזה דורש הערכה רפואית מיידית במיון נשים (טלפון: 03-5028318).

תגיות: דימום מוגבר, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: יש לי חום מעל 38°C שלא יורד גם אחרי שלקחתי משככי כאבים (אקמול/אופטלגין/נורופן). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. חום שאינו מגיב לטיפול דורש שלילת זיהום במיון נשים באופן מיידי (טלפון: 03-5028318).

תגיות: חום, משככי כאבים, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני מרגישה כאב חריג או בלתי נסבל שלא משתפר עם משככי כאבים רגילים. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: כאב עז, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: יש לי הפרשה נרתיקית חריגה מאוד (ריח רע, כמות גדולה או צבע מוזר). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת עשוי להעיד על זיהום ומצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: הפרשה חריגה, ריח רע, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני חווה חולשה משמעותית, עילפון, סחרחורת או נפילה. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה עקב חשש לאובדן דם משמעותי או תגובה המודינמית. יש לגשת במייד למיון נשים (טלפון: 03-5028318).

תגיות: עילפון, סחרחורת, חולשה, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני חווה קוצר נשימה או קושי בדיבור. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מחייב בדיקה רפואית דחופה ביותר. יש לגשת במייד למיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: קוצר נשימה, דגל אדום, מיון, דחוף

שאלה: מהם סימני הזיהום שדורשים פנייה למיון?

תשובה: שילוב של חום, צמרמורות, דימום מוגבר והפרשה חריגה מהווים דגל אדום. במקרה כזה יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: זיהום, חום, צמרמורות, דגל אדום

8. רקע רפואי ומצבים מיוחדים

לפני תחילת הליך של הפסקת הריון, חיוני לשקלל את ההיסטוריה הרפואית שלך. מחלות כרוניות, הפרעות קרישה או מיקומים חריגים של ההריון (כמו בצלקת ניתוחית) משפיעים על בחירת שיטת הטיפול ורמת המעקב הנדרשת.

שאלה: יש לי רקע רפואי מיוחד (מחלה כרונית, הפרעות קרישה, טיפול במדללי דם או אירוע מוחי בעבר). האם זה משפיע על הטיפול?

תשובה: כן, רקע רפואי מורכב מחייב התאמה אישית של הטיפול. עליך להפנות את המידע לרופא הנשים שלך או לרופא המטפל בביקור הראשון בבית החולים טרם התחלת התהליך. ניתן ליצור קשר עם מזכירות המרפאה לתיאום: 03-5028490.

תגיות: רקע רפואי, הפרעות קרישה, מחלות כרוניות, בטיחות

שאלה: מה המשמעות של הריון חוץ רחמי או הריון בצלקת ניתוח קיסרי?

תשובה: מצבים אלו הם מצבי חירום רפואיים שאינם מטופלים בהפסקת הריון רגילה. במידה ואובחנת עם הריון חוץ רחמי או הריון בצלקת, יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: הריון חוץ רחמי, הריון בצלקת, דגל אדום, מיון

9. אורח חיים, פוריות ותכנון עתידי

הגרידה אינה פוגעת בפוריות העתידית, והגוף חוזר למעגל הורמונלי תקין תוך זמן קצר. עם זאת, יש להקפיד על היגיינה למניעת זיהומים שיכולים להשפיע על בריאות הרחם. הביוץ יכול להתרחש כשבועיים בלבד לאחר הפעולה, ולכן ישנה חשיבות להתאמת אמצעי מניעה מיידית.

שאלה: האם ישנן הגבלות לאחר הפעולה? לכמה זמן?

תשובה: יש להימנע מטבילה בים, בבריכה או באמבטיה למשך שבועיים כדי למנוע זיהום. וכן יש להמנע מקיום יחסים למשך כשבועיים. מקלחת רגילה מותרת ואף מומלצת.

תגיות: הגבלות, רחצה

שאלה: מתי אפשר לחזור לקיים יחסי מין?

תשובה: מומלץ להימנע מקיום יחסים למשך כשבועיים לאחר הפעולה (או עד שהדימום פוסק) על מנת להפחית את הסיכון לזיהום בררם.

תגיות: יחסי מין

שאלה: למה אני צריכה ללכת לרופא נשים שלי לאחר הוסת?

תשובה: לעיתים נותרת שארית קטנה שלא זוהתה קודם. הבדיקה המיטבית לזיהוי כזה נעשית מיד בסיום הווסת הראשונה.

תגיות: שארית, ביקורת

שאלה: מתי יגיע הוסת? מתי צפוי המחזור הראשון?

תשובה: בדרך כלל תוך 4-6 שבועות. אם לא הגיע מחזור תוך 6-8 שבועות, פני לרופא.

תגיות: וסת, מחזור ראשון

שאלה: מתי אפשר להתחיל ליטול אמצעי מניעה?

תשובה: ניתן להתחיל אמצעי מניעה הורמונלי עוד ביום הפעולה. מומלץ להתייעץ עם רופא לגבי הסוג המתאים.

תגיות: אמצעי מניעה, גלולות

שאלה: למה משמש סוג הדם שלי? מה המשמעות של סוג דם שלי (RH NEG)?

תשובה: סוג הדם קובע אם נדרשת זריקת אנטי-D (במקרה של RH שלילי) בתוך 72 שעות מהפעולה, כדי למנוע סיבוכים בהריונות עתידיים.

תגיות: Rh, סוג דם, אנטי-D

10. השוואת שיטות וסיכומים

הבחירה בין הגישה התרופתית לכירורגית מבוססת על שקלול של גיל ההריון, המצב הרפואי והעדפת המטופלת. בעוד שהשיטה התרופתית נתפסת כפרטית יותר, פחות פולשנית וללא השפעה עתידית על הפריון, השיטה הכירורגית מציעה הליך קצר עם אחוזי הצלחה גבוהים בפעולה אחת.

שאלה: יתרונות הטיפול התרופתי?

תשובה: הימנעות מפעולה פולשנית והרדמה כללית, אפשרות לביצוע בבית בסביבה פרטית, וללא השפעה על פוריות עתידית.

תגיות: יתרונות, ללא ניתוח

שאלה: מה החסרונות של הטיפול התרופתי?

תשובה: סיכון לכישלון או שארית המצריכים ניתוח, משך זמן ארוך (מספר שבועות), וכאב ודימום משמעותי למשך מספר ימים.

תגיות: חסרונות, שארית

שאלה: האם הטיפול בטוח? האם יש פגיעה לאם או לעובר הבא?

תשובה: כן, הפסקת הריון המבוצעת באופן מוסדר היא הליך בטוח ביותר. אין עדות לפגיעה בפוריות העתידית או בבריאות העובר בהריון הבא.

תגיות: בטיחות, פוריות עתידית

שאלה: האם בעקבות הטיפול יש סכנה להריון חוץ רחמי?

תשובה: לא, הטיפול אינו מעלה שכיחות של הריון חוץ-רחמי בעתיד.

תגיות: הריון חוץ-רחמי, סיכונים עתידיים

שאלה: האם הטיפול בגרידה מתאים גם להריון חוץ רחמי?

תשובה: לא, גרידה מיועדת לריקון חלל הרחם בלבד, הריון חוץ רחמי הוא הריון שממוקם לרוב בחצוצרות ועל כן אינו מתאים לטיפול בגרידה.

תגיות: הריון חוץ רחמי, חצוצרה

שאלה: אני אחרי ניתוח קיסרי, האם יש עדיפות לגרידה על פני טיפול תרופתי?

תשובה: באופן כללי, אין עדיפות גורפת לשיטה אחת על פני השנייה רק בשל קיומו של ניתוח קיסרי בעבר. בשליש הראשון, הטיפול התרופתי נחשב לבטוח מאוד ואינו כרוך בסיכון מוגבר לקרע של הרחם. גם הפעולה הכירורגית (גרידה) נחשבת לבטוחה, אם כי לעיתים היא עשויה להיות מאתגרת יותר מבחינה טכנית עבור הרופא בשל הידבקות אפשריות בחלל הבטן או שינויים במבנה צוואר הרחם בעקבות הניתוח. הנקודה החשובה ביותר היא ביצוע אולטרה-סאונד מקדים כדי לוודא ששק ההיריון אינו ממוקם על הצלקת עצמה. במידה וההיריון ממוקם כראוי בתוך חלל הרחם, הבחירה בין השיטות תתבצע לפי גיל ההיריון והעדפתך האישית.

תגיות: ניתוח קיסרי, בטיחות הטיפול, הריון בצלקת, גרידה, טיפול תרופתי.

11. גרידה דחופה (מצבי חירום)

במצבים רפואיים מסוימים, כגון דימום מאסיבי שאינו פוסק, חשד לזיהום רחמי סוער או חוסר יציבות המודינמית (צניחת לחץ דם עקב איבוד דם), נדרש ריקון מיידי של חלל הרחם באמצעות גרידה דחופה. בניגוד לפעולה מוזמנת (אלקטיבית), גרידה דחופה מבוצעת בטווח זמן קצר מאוד מרגע האבחנה במיון. במצבים מסכני חיים, הפעולה תבוצע גם ללא שהיית צום מלא, תוך נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים על ידי צוות המרדמים להגנה על דרכי הנשימה. מטרת העל של ההליך היא עצירת הדימום וסילוק מקור הזיהום באופן מיידי.

שאלה: מתי יומלץ לי לעבור גרידה דחופה?

תשובה: גרידה הופכת לדחופה כאשר המטופלת מציגה סימני סכנה המצריכים התערבות מיידי: דימום כבד ביותר שאינו מגיב לטיפול שמרני, חום גבוה המלווה בכאבי בטן עזים (חשד לזיהום רחמי), או מצב של חולשה קיצונית וערפול הכרה עקב איבוד דם רב. במקרים אלו, הפעולה מבוצעת בטווח של דקות עד שעות ספורות מרגע ההגעה למיון.

תגיות: גרידה דחופה, מצב חירום, דימום כבד, זיהום רחמי

שאלה: איך מתכננים לגרידה דחופה? האם צריך לצום?

תשובה: במצבי חירום מסכני חיים, הפעולה תבוצע גם אם המטופלת אינה בצום מלא, תוך שימוש בטכניקות הרדמה שונות. במידה והמצב הקליני מאפשר המתנה קצרה, המטופלת תתבקש להימנע מאוכל ושתייה מרגע ההחלטה על הפעולה. במיון יבוצעו בדיקות דם דחופות, הכנה לעירוי נוזלים רחב ומתן מוצרי דם במידת הצורך.

תגיות: גרידה דחופה, צום, הכנה לניתוח

שאלה: מה קורה במיון לפני שנכנסים לגרידה דחופה?

תשובה: במיון תבוצע הערכה מהירה הכוללת אולטראסאונד לווידוא שארית תוכן ברחם ובדיקת מדדים (דופק ולחץ דם). המטופלת תקבל עירוי נוזלים, אנטיביוטיקה לווריד במידה ויש חשד לזיהום, ותעבור הערכה מהירה של מרדים לפני המעבר המייד לחדר הניתוח.

תגיות: מיון נשים, תהליך, גרידה דחופה

שאלה: האם ההתאוששות מגרידה דחופה שונה מגרידה רגילה?

תשובה: הפעולה הכירורגית עצמה דומה, אך ההתאוששות עשויה לכלול אשפוז ארוך יותר (לרוב 24 שעות או יותר) לצורך השגחה צמודה על המדדים ועצירת הדימום. במידה והיה איבוד דם משמעותי, יבוצע מעקב אחר רמת ההמוגלובין וייתכן צורך במתן ברזל או עירוי דם לפני השחרור. במידה וניתנה אנטיביוטיקה עקב זיהום, תתבקש להמשיך את הטיפול בבית.

תגיות: התאוששות, אשפוז, המוגלובין, גרידה דחופה

שאלה: האם גרידה דחופה מסוכנת יותר מגרידה רגילה?

תשובה: הסיכון המרכזי בגרידה דחופה נובע מהמצב הרפואי שבגללו היא מבוצעת (כמו הדימום או הזיהום) ולא מהפעולה עצמה. עם זאת, הרדמה ללא צום מלא כרוכה בסיכון מעט גבוה יותר לשאיפת תוכן קיבה לריאות (אספירציה), אך צוות המרדמים מיומן בנקיטת פעולות למניעת סיבוכי זה. מבחינת הרחם, הפעולה בטוחה באותה מידה.

תגיות: סיכונים, הרדמה, בטיחות

שאלה: הגעתי למיון עם דימום בהריון ולקחו אותי לגרידה דחופה. למה?

תשובה: כאשר מופיע דימום כבד מאוד במהלך ההריון, זהו לרוב סימן לכך שהרחם מנסה להתרוקן אך רקמה מסוימת נותרה בפנים. הרקמה הזו מונעת מהרחם להתכווץ ולהיסגר, ולכן הדימום לא פוסק. במקרים אלו, כדי למנוע איבוד דם משמעותי שעלול לסכן אותך ולגרום לחולשה קיצונית או סחרחורות, הצוות הרפואי

מבצע גרידה דחופה. מטרת הפעולה היא לרוקן את הרחם באופן מיידי כדי שהדימום ייעצר והגוף יוכל להתחיל בתהליך ההחלמה וההתאוששות.

תגיות: גרידה דחופה, דימום כבד, הפלה לא שלמה, בטיחות המטופלת.

12. גרידה בשליש השני (D&E) ושימוש בלמינריות

הליך ה-D&E (Dilation and Evacuation) הוא השיטה הכירורגית להפסקת הריון בשליש השני (משבוע 14 ועד שבוע 19 מלא). בשבועות אלו, צוואר הרחם דורש הכנה הדרגתית ומבוקרת באמצעות למינריות – מרחיבים היגרוסקופיים הסופחים נוזלים ומתרחבים באיטיות. שיטה זו מונעת פציעה של צוואר הרחם ומאפשרת ריקון בטוח תחת הרדמה מלאה.

שאלה: מהי פעולת D&E?

תשובה: D&E היא פעולה כירורגית לריקון הרחם בשליש השני של ההריון. הפעולה מבוצעת בחדר ניתוח גדול תחת הרדמה כללית וכוללת הרחבה מוקדמת של צוואר הרחם, ביום טרם הפעולה, ושימוש במכשור ייעודי תחת הנחיית אולטראסאונד בטני.

תגיות: D&E, גרידה בשליש שני

שאלה: מהן למינריות ומדוע הן נחוצות?

תשובה: למינריות הן מקלונים קטנים שנספגים בנוזלים ומתרחבים באיטיות בתוך צוואר הרחם. הן נחוצות ב-D&E כדי להשיג הרחבה הדרגתית ובטוחה של צוואר הרחם, המונעת נזק מכני ומאפשרת את הפעולה הכירורגית. אם את מיועדת לעבור גרידה בין שבועות 13 ל-19 תזומני לאשפוז יום קודם הפעולה לצורך השמת למינריות ע"י רופא נשים בשעות הערב להכנה לקראת הפעולה. כדאי לדעת שהכנסת הלמינריות היא פעולה כואבת הנמשכת כ-5 דקות, בבית חולים וולפסון ניתן לבקש לעבור את הכנסת הלמינריות לאחר קבלת שיכוך כאב כדוגמת וולטרן או תחת גז צחוק.

תגיות: למינריות, הכנת צוואר הרחם, אשפוז יום קודם

שאלה: כמה זמן מראש מחדירים את הלמינריות?

תשובה: הלמינריות מוחדרות בדרך כלל בשעות האחה"צ יום לפני הפעולה הניתוחית. בשבועות מתקדמים (16-19), ייתכן צורך בהחדרה בשני שלבים נפרדים בהפרש של מספר שעות.

תגיות: למינריות, שלבי הכנה

שאלה: מתי עלי להתאשפז לקראת גרידת D&E?

תשובה: בהפסקת הריון משבוע 14 ומעלה, עלייך להתאשפז במחלקת נשים בצהרי היום שלפני הפעולה (בדרך כלל עד 14:00) לצורך החדרת הלמינריות ומעקב.

תגיות: אשפוז, לוח זמנים

שאלה: האם עלי להיות בצום לקראת פעולת D&E?

תשובה: כן, יש להישאר בצום מוחלט מוחלט (אוכל ושתייה) 8 שעות טרם הפעולה. ניתן לשתות מים צלולים עד שעתיים לפני הפעולה.

תגיות: צום, D&E

שאלה: עד איזה שבוע ניתן לבצע גרידה מסוג D&E?

תשובה: במרכז הרפואי וולפסון פעולת ה-D&E מבוצעת עד לשבוע 19 מלא. הפסקות הריון מעבר לשבוע 20 מתבצעות בשיטות שונות במסגרת האשפוז על פי שיקול דעת רופא הנשים, ולא בגרידה או שאיבה.

תגיות: גיל הריון, שבוע 20

שאלה: האם יש דרך אחרת למעט למינריות?

תשובה: ניתן להשתמש באמצעים תרופתיים כמו מיסופרוסטול (ציטוטק) לריכוך צוואר הרחם, אם כי בשבועות מתקדמים אלו (מעל שבוע 14) מקובל להשתמש במרחיבים מכניים (למינריה) כדי להבטיח הרחבה מספקת ובטוחה של הצוואר לקראת הפעולה הכירורגית, הרחבה לא מספקת לא תאפשר את השלמת הפעולה בבטחה ותעלה את הסיכוי לשארית ולסיבוכים. **תגיות:** למינריה, הכנת צוואר הרחם, חלופות, ציטוטק.

שאלה: מה קורה במהלך האשפוז לקראת הפסקת הריון בשבוע 14-19?

תשובה: התהליך מתפרס בדרך כלל על פני יומיים. ביום הראשון (יום הקבלה), תגיעי למחלקת נשים בשעות הצהריים. תעברי הערכה רפואית הכוללת בדיקת סימנים חיוניים, אולטרה-סאונד ושיחה עם רופא. בשעות אחר הצהריים וכתלות בגיל ההריון פעם נוספת בלילה יוחדרו הלמינריות לצוואר הרחם בחדר בדיקה, ניתן לעבור שאת לאחר קבלת משככי כאב או תחת גז צחוק. לאחר מכן תישארי להשגחה במחלקה, תקבלי ארוחת ערב ותתחילי צום מחצות הלילה. ביום השני (יום הפעולה), תועברי לחדר ניתוח לביצוע הגרידה (D&E) תחת הרדמה כללית, טרם להעברתך לחדר ניתוח תקבלי שני כדורים ציטוטק (400 mcg misoprostol) להשמה מתחת לשון לצורך ריכוך צוואר הרחם. לאחר הפעולה תשהי בחדר התאוששות

כשעתיים ולאחר מכן תחזרי למחלקה למעקב של מספר שעות. במידה ומצבך יציב והדימום תקין, תשוחזרי לביתך בשעות אחר הצהריים או הערב.

תגיות: אשפוז, תהליך, וולפסון, D&E, הכנה לניתוח.

13. תמיכה רגשית ובריאות הנפש

הפסקת היריון, גם כשהיא מבוצעת בהליך כירורגי (גרידה), מלווה לעיתים קרובות בתנודות רגשיות הנובעות משילוב של צניחה הורמונלית חדה והתהליך האישי המורכב שעברת. רגשות של עצב, הקלה, אשמה או בלבול הם טבעיים ולגיטימיים לחלוטין. חשוב לתת לעצמך את הזמן והמרחב לעבד את החוויה ולהיעזר בתמיכה מהסביבה הקרובה או מהצוות המקצועי בבית החולים במידת הצורך.

שאלה: האם יש תמיכה נפשית בבית חולים וולפסון לאחר הגרידה?

תשובה: כן, בבית חולים וולפסון עומד לרשותך צוות של עובדות סוציאליות שניתן להיעזר בהן לתמיכה רגשית וליווי סביב התהליך. ניתן לפנות לשירות הסוציאלי דרך צוות המחלקה.

תגיות: תמיכה רגשית, שירות סוציאלי, וולפסון

שאלה: זה נורמלי שאני מרגישה כל כך עצובה ובוכה אחרי הפעולה?

תשובה: כן, זה טבעי להרגיש עצב עמוק ודכדוך. הפסקת היריון היא אירוע מטלטל, והצניחה ההורמונלית שאחריה משפיעה גם היא על מצב הרוח. בדרך כלל העצב החזק נחלש בהדרגה ככל שעובר הזמן.

תגיות: עצב, בכי, החלמה רגשית

שאלה: אני מרגישה רגשות אשם או חרטה. האם התחושות האלה רגילות?

תשובה: תחושות אלו נפוצות מאוד, אפילו אם היית משוכנעת שזה הצעד הנכון. לגמרי נורמלי להרגיש אשמה או לתהות אם עשית נכון. עם הזמן, רוב הנשים לומדות לקבל את המציאות והרגשות הקשים נרגעים.

תגיות: אשמה, חרטה, רגשות

שאלה: אני כועסת – למה דווקא לי זה קרה – ואני אפילו מקנאה בנשים בהריון. זה נורמלי לכעוס ככה?

תשובה: כן, תחושות כעס, תסכול וקנאה הן טבעיות לחלוטין. הרבה נשים שואלות "למה זה קרה דווקא לי?". זהו חלק מתהליך ההתמודדות עם האובדן או התהליך, והכעס לרוב שוכך עם הזמן.

תגיות: כעס, קנאה, תסכול

שאלה: אני פשוט לא מרגישה כלום מאז הגרידה. זה בסדר?

תשובה: תחושת קהות או ניתוק רגשי אינה נדירה. לעיתים הנפש נכנסת למצב "הגנה" טבעי כדי למנוע כאב מיידית. בדרך כלל הרגשות חוזרים בהדרגה. אם התחושה לא חולפת לאחר מספר שבועות, מומלץ לשוחח על כך עם איש מקצוע.

תגיות: קהות רגשית, ניתוק, הגנה

שאלה: אני ובן הזוג שלי מתווכחים המון מאז המקרה. האם זה קשור?

תשובה: כן, האירוע יכול ליצור מתח רב במערכת היחסים. כל אחד מבני הזוג עשוי לעבד את החוויה בצורה שונה, מה שמוביל לעיתים לאי-הבנות. חשוב לנסות לדבר על התחושות בפתיחות.

תגיות: זוגיות, מתח, תקשורת

שאלה: קשה לי מאוד לראות תינוקות או נשים בהריון כרגע. האם אני צריכה להימנע מהם?

תשובה: זוהי תגובה נורמלית לחלוטין של הגנה עצמית. נשים רבות חוות "טריגר" למראה סממנים של היריון או הורות מיד לאחר התהליך. מותר לך לקחת פסק זמן ולהימנע מסיטואציות שקשות לך עד שתרגישי חזקה יותר. תגיות: טריגרים, הגנה עצמית, הימנעות

שאלה: האם זה בסדר לחזור לקיים יחסי מין אם אני עדיין מרגישה עצובה?

תשובה: מבחינה רפואית יש להמתין כשבועיים (עד לאחר הביקורת), אך מבחינה רגשית - רק את ובן זוגך תדעו מתי זה מרגיש נכון. יש נשים שהאינטימיות מנחמת אותן ואחרות זקוקות לזמן ארוך יותר.

תגיות: אינטימיות, יחסי מין, רגש

שאלה: אני מרגישה ריקנות גדולה בגוף ובנפש. איך ממלאים את זה?

תשובה: תחושת הריקנות היא חלק מתהליך האבל על האובדן. חשוב לתת לעצמך זמן ולא "לזרז" את המילוי מחדש. חזרה הדרגתית לפעילויות שאת אוהבת וטיפול עצמי (מנוחה, תזונה) יעזרו לתחושה להתפוגג.

תגיות: ריקנות, אבל, טיפול עצמי

14. ביטויי מצוקה (דגלים אדומים)

בדומה לסיבוכים פיזיים, קיימים מצבי מצוקה רגשית הדורשים התייחסות מקצועית. אם חלוף הזמן לא מביא הקלה, אם ישנה פגיעה בתפקוד היומיומי, הפרעות שינה קשות או תחושת ייאוש, מומלץ לפנות לייעוץ רגשי דרך שירותי בריאות הנפש או השירות הסוציאלי כדי לקבל כלים להתמודדות וחזרה לאיזון.

שאלה: "מצב הרוח שלי לא משתפר, אני מרגישה ככה כבר הרבה זמן" / "עברו כמה שבועות ואני לא מרגישה הקלה"

תשובה: ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי נמשך ומתחיל להשפיע עלייך. בשלב כזה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש. פנייה לפסיכולוגית או לעובדת סוציאלית היא צעד מקובל ונכון.

תגיות: מצוקה מתמשכת, דגל אדום

שאלה: "קשה לי לתפקד ביום-יום" / "אפילו דברים קטנים מרגישים לי בלתי אפשריים"

תשובה: ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי משפיע על התפקוד שלך. מומלץ לפנות לתמיכה מקצועית שתעזור לך לחזור לשגרה ולכוחות שלך.

תגיות: פגיעה בתפקוד, דגל אדום

שאלה: "אני מרגישה מוצפת כמעט כל הזמן" / "אני לא מסתדרת עם זה לבד"

תשובה: הצפה רגשית היא סימן לכך שהעומס גדול מדי כרגע. מומלץ לפנות לעזרה מקצועית דרך רופא המשפחה או השירות הסוציאלי בוולפסון לקבלת כלים להתמודדות.

תגיות: הצפה רגשית, דגל אדום

שאלה: "אני מרגישה לבד לגמרי וחסרת תקווה"

תשובה: תחושת בדידות עמוקה או חוסר תקווה הן נורות אזהרה למצוקה. פנייה לגורם טיפולי יכולה לספק מרחב בטוח לשיתוף וקבלת תמיכה מקצועית שתעזור לך לראות את הדרך קדימה.

תגיות: בדידות, ייאוש, דגל אדום

15. מידע שימושי ואנשי קשר במרכז הרפואי וולפסון

ריכוז פרטי ההתקשרות של היחידות השונות במרכז הרפואי וולפסון מאפשר לך לקבל מענה מהיר בכל שעה. לכל צורך – החל מזימון תורים ועד למצבי חירום בלילה – קיים ערוץ תקשורת ייעודי.

שאלה: מהו מספר הטלפון של מיון נשים בוולפסון ומתי הוא פעיל?

תשובה: מיון נשים פעיל 24/7. טלפון: 03-5028318 (דחוף) או 03-5028490. כתובת: הלוחמים 62, חולון.

תגיות: מיון נשים, טלפון, וולפסון, 24/7

שאלה: איך ניתן ליצור קשר עם מרפאת הנשים (לא בשעות חירום)?

תשובה: המרפאה פעילה בימים א'-ה' בין השעות 08:00–14:30.

- טלפון: 03-5028490
- WhatsApp (הודעות בלבד): 03-5028111
- מייל: Nashimirp@wmc.gov.il
- **תגיות:** מרפאת נשים, וואטסאפ, שעות פעילות

שאלה: איך פונים לשירות הסוציאלי בוולפסון?

תשובה: השירות הסוציאלי פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00–15:30.

- טלפון: 03-5028455
- מייל: vaadas@wmc.gov.il
- **תגיות:** שירות סוציאלי, עובדת סוציאלית

שאלה: איך מזמנים תור להליך או לוועדה?

תשובה: ניתן לזמן תורים בטלפון 03-5028111 או דרך האתר:
<https://www.gov.il/he/service/wolfson-book-medical-appointment>

ניתן גם לפנות לשירות הסוציאלי בוולפסון לקבלת הדרכה ועזרה.

תגיות: זימון תורים, וועדה

שאלה: כיצד ניתן לפנות לוועדה להפסקת הריון במרכז הרפואי וולפסון?

תשובה: ניתן לפנות לוועדה בשתי דרכים, וועדה פרונטלית או הליך מקוון. הליך מקוון יכול להתבצע במידה וגיל ההריון מתחת לשבוע 24.

לשם ביצוע הליך מקוון באמצעות מערכת הזיהוי הממשלתית, ללא צורך בהגעה פיזית, יש להצטייד בפרטים הבאים:

1. תעודת זהות, כאשר הסיבה להגשת הבקשה הינה הריון מחוץ לנישואים, נדרשת הצגת ספח תעודת זהות.

2. מסמכים מבדיקת רופא/ת נשים המעידים על הריון

3. תמונת אולטרה סאונד שעליה מופיע שם המטופלת

4. מסמכים רפואיים אחרים (אם הסיבה לבקשת אישור הועדה נובעת מהחשש כי הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי (סעיף 3 לחוק, או משום שההיריון מהווה סיכון לחיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי (סעיף 4 לחוק).

תוצאות בדיקות דם שנלקחו במסגרת קופת חולים או מרפאה צבאית: סוג דם, ספירת דם ו-RH. בדיקות הדם אינן נדרשות לצורך קבלת אישור הועדה, אלא לביצוע הפסקת ההריון.

טופס 17 לוועדה (קוד L0209) או אסמכתא תקציבית מהצבא.

חברות קופ"ח מכבי אינן נדרשות להציג טופס 17.

עבור הפונות לוועדה פרונטלית (בבית החולים):

הוועדה מתקיימת מס' פעמים בשבוע בימי ראשון, שלישי וחמישי, ומתקיימת בבניין מרפאות חוץ, קומה ראשונה.

לתיאום התור יש להתקשר בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8-15.30 למזכירת השירות הסוציאלי בטלפון 03-5028455, שלוחה 2.

ניתן לפנות גם באמצעות המייל - מזכירות השירות הסוציאלי: vaadas@wmc.gov.il

מזכירת הועדה תהיה אתך בקשר, ותוכלי להתייעץ עם רופא/ת הועדה אונליין. אישור הועדה מתקבל באופן דיגיטלי, וניתן לפנות איתו לקביעת תור לביצוע גם בבתי חולים אחרים.

תגיות: ועדה להפסקת הריון, השירות הסוציאלי וולפסון, זימון תור, מסמכים